

LAS CUATRO FASES DEL GRAN ATAQUE HISTÉRICO

Descripción clínica

Les Démoniaques dans l'art

J.-M. Charcot y P. Richer · París, Adrien Delahaye et Émile Lecrosnier, 1887

Autores: Jean-Martin Charcot (1825-1893) y Paul Richer (1849-1933).

Obra: *Les Démoniaques dans l'art* (1887), pp. 91-101: la descripción clínica del ataque completo y regular, con la que los autores cierran su estudio sobre las representaciones artísticas de la posesión.

Traducción: Cátedra de Psicopatología I, UFLO Online, 2026, desde el original francés, que es de dominio público.

Establecimiento del texto: transcripción validada al 100 % en Wikisource francés, cotejada contra el facsímil de la edición original.

Advertencia: este **no** es el texto que el programa cita por la compilación de J. Saurí. Es otro texto de Charcot, del mismo período, elegido porque desarrolla la semiología del ataque —que es lo que esta clase necesita— y porque su original es accesible y verificable.

Unidad: Unidad 2 — El síntoma y la histeria · Clase 5: Histeria y Dora: síntoma, fantasía y transferencia.

Por qué leemos este texto

Charcot y Richer escriben este libro para sostener una tesis histórica: que los endemoniados que el arte representó durante siglos eran histéricos, y que sus contorsiones responden a una regularidad que la clínica puede describir. Para demostrarlo necesitan exponer, al final del libro, cómo es el ataque tal como ellos lo observan en la Salpêtrière. Esa descripción es lo que leemos.

Lo que nos importa no es el cuadro en sí, sino un detalle del que los autores no extraen todas las consecuencias. Al describir la segunda fase, la de las contorsiones, la llaman de actitudes *ilógicas*, y la distinguen expresamente de la tercera, las *actitudes pasionales*, que —escriben— «son siempre la representación de una idea o de un sentimiento».

Es decir: en medio de una descripción puramente morfológica, Charcot anota que hay una fase del ataque que **representa algo**. Que el cuerpo, ahí, escenifica. Él lo consigna como un rasgo semiológico más, uno que sirve para clasificar. Freud va a tomar ese mismo hecho y preguntarle qué representa, para quién y por qué; y las actitudes pasionales dejarán de ser una fase del cuadro para volverse la puesta en escena de una fantasía. Ese desplazamiento —de la forma al sentido, de la mirada a la escucha— es lo que estudiamos en esta clase con Dora.

Léanlo, entonces, prestando atención a dos cosas: cuánto ve Charcot, y dónde se detiene.

LAS CUATRO FASES DEL GRAN ATAQUE HISTÉRICO

[La descripción que sigue cierra *Les Démoniaques dans l'art*. Los autores remiten con frecuencia a las láminas del libro, que no se reproducen aquí; las referencias a figuras se han suprimido.]

Los pródromos y el aura

Nuestra descripción será lo más sucinta posible. El ataque histérico completo y regular se compone de cuatro períodos; está precedido las más de las veces por signos precursores que permiten a los enfermos prever el momento en que van a caer en estado de crisis.

Estos pródromos aparecen a veces varios días antes. La enferma, cuando se trata de una mujer, es tomada por malestares, inapetencia, a veces vómitos. Se vuelve taciturna, melancólica, o por el contrario es presa de una sobreexcitación extrema.

Las alucinaciones de la vista son frecuentes; consisten sobre todo en visiones de animales: gatos, ratas, víboras, cuervos. Se ven sobrevenir a veces calambres, temblor limitado a un miembro o sacudidas de todo el cuerpo acompañadas de vértigo. Pronto se muestran los fenómenos dolorosos del aura histérica, que preceden inmediatamente al ataque y que aparecen en general en el orden siguiente: dolor ovárico, irradiaciones hacia el epigastrio, palpitaciones cardíacas, sensación de globo histérico en el cuello, silbidos de oídos, sensación de golpes de martillo en la región temporal, obnubilación de la vista. Luego la pérdida del conocimiento marca el comienzo del ataque, que se desarrolla como sigue.

1.º Período epileptoide

Este período se parece hasta confundirse con el ataque de epilepsia verdadera: convulsiones tónicas, clónicas, luego estertor. Cabe por lo tanto subdividirlo en tres fases: la fase tónica, la fase clónica y la fase de resolución.

La fase tónica comienza las más de las veces por algunos movimientos de circunducción de los miembros superiores e inferiores, al mismo tiempo que sobrevienen la pérdida del conocimiento, la detención momentánea de la respiración, la palidez y luego el enrojecimiento del rostro, la hinchazón del cuello, la convulsión hacia arriba de los globos oculares, la distorsión de la cara y a veces la protrusión de la lengua. Esta fase termina por la inmovilización tetánica de todo el cuerpo en una actitud cuya forma más frecuente es la extensión del tronco y de los miembros, pero que puede variar. La espuma se muestra en los labios.

Enseguida se ven los miembros rígidos animados por oscilaciones breves y rápidas, cuya amplitud aumenta por grados y que terminan en grandes sacudidas generalizadas: es **la fase clónica**. Los músculos de la cara, animados por los mismos movimientos, vuelven la fisonomía horriblemente gesticulante.

Finalmente los movimientos se apaciguan y comienza **la fase de resolución**, durante la cual el rostro permanece hinchado y manchado de espuma, los ojos están cerrados y todos los músculos en la resolución más completa. Al mismo tiempo la respiración se vuelve estertorosa.

Esta primera parte del drama, que constituye el ataque de gran histeria, se ha desarrollado en un espacio de tiempo bastante corto. Las dos primeras fases no duran más de un minuto; la fase de resolución se prolonga a veces dos o tres minutos.

2.º Período de las contorsiones y de los grandes movimientos, o período de clownismo

Tras un momento de calma bastante corto que sigue al estertor, comienza el segundo período. Está constituido por dos órdenes de fenómenos distintos —las contorsiones y los grandes movimientos— que por procedimientos diferentes responden a un mismo principio, dominante en todo este período, y buscan un mismo resultado: un gasto exagerado de fuerza muscular. No es demasiado decir que los enfermos se entregan entonces a verdaderas proezas, y el nombre de *clownismo* con que igualmente lo designamos nos parece plenamente legitimado.

Durante las diversas fases de este período los enfermos muestran una soltura, una agilidad, una fuerza muscular muy capaces de asombrar al espectador y, en la mujer, a menudo en completa oposición con la apariencia endeble del sujeto. Estos fenómenos habían impresionado vivamente a los primeros observadores, testigos de las agitaciones de los poseídos: encontramos en el Ritual de los exorcismos que uno de los signos de la posesión demoníaca consistía en el desarrollo de fuerzas físicas superiores a la edad y al sexo de la persona en quien se manifiestan.

Las contorsiones consisten en actitudes extrañas, imprevistas, inverosímiles. Entre esas actitudes, que hemos calificado también de *ilógicas* —para distinguirlas de las actitudes del tercer período, del que se hablará enseguida, las *actitudes pasionales*, que son siempre la representación de una idea o de un sentimiento—, hay una por la que los enfermos parecen tener una preferencia marcada; se reproduce tanto en los hombres como en las mujeres y casi del mismo modo, y merece el nombre de *arco de círculo*. El enfermo está fuertemente curvado hacia atrás, los pies y la cabeza reposan solos sobre la cama, y el vientre, a veces meteorizado, forma la cima de la curva.

La contorsión puede además inmovilizar al paciente en las actitudes más variadas. Si tuviéramos que marcar al respecto una diferencia entre los dos sexos, diríamos que en los hombres predominan las actitudes de extensión, mientras que en las mujeres son las de flexión.

Los grandes movimientos consisten las más de las veces en oscilaciones rápidas y amplias de toda una parte del tronco o solo de los miembros. El más frecuente es este: el enfermo se endereza como para sentarse; la cabeza desciende hasta el nivel de las rodillas y luego se echa bruscamente hacia atrás golpeando con violencia la almohada. Este movimiento se repite un gran número de veces seguidas, simulando una serie de *saludos* exagerados. Estos grandes movimientos revisten a veces un carácter particularmente acrobático: volteretas, saltos de carpa. Pero tienen siempre ese carácter de repetirse cierto número de veces seguidas. A menudo están precedidos o interrumpidos por gritos automáticos cuyo timbre penetrante recuerda el silbato del ferrocarril.

Otras veces, en fin, ningún ritmo preside estos grandes movimientos. Son completamente desordenados. El enfermo parece luchar contra un ser imaginario, busca romper los lazos que lo retienen. Es una verdadera crisis de rabia contra sí mismo o contra los otros; son gritos salvajes, aullidos de bestia. Busca morder y golpear. Hace pedazos todo lo que alcanza —las sábanas, la ropa—; las mujeres se arrancan los cabellos a puñados.

La exageración y el predominio de este período constituyen la *variedad demoníaca* del gran ataque histérico.

3.º Período de las actitudes pasionales

La alucinación preside manifiestamente este tercer período. El enfermo entra él mismo en escena, y por la mímica expresiva y animada a la que se entrega, por las frases entrecortadas que se le escapan, es fácil seguir todas las peripecias del drama al que cree asistir y en el que juega el papel principal.

Cuando se trata de una mujer, dos órdenes de ideas bien diferentes se reparten ordinariamente las alucinaciones; el cuadro tiene dos caras, una alegre y otra triste.

En el orden alegre, la enferma se cree por ejemplo transportada a un jardín magnífico, una suerte de Edén donde a menudo las flores son rojas y los habitantes están vestidos de rojo. Allí se toca música. La enferma encuentra el objeto de sus sueños o de sus afectos anteriores, y a veces siguen escenas de amor. Pero esta parte erótica falta a menudo y en todo caso no cumple, como se ve, sino un papel

absolutamente secundario en medio de las manifestaciones tan numerosas y variadas que constituyen el gran ataque histérico. Los cuadros tristes son incendios, la guerra, las revoluciones, asesinatos; casi siempre hay sangre derramada.

En los hombres, estas visiones lúgubres y aterradoras ocupan casi por sí solas todo el tercer período. Las alucinaciones alegres son, por así decir, excepcionales.

4.º Período terminal

Después del período de las actitudes pasionales, o poses plásticas, puede decirse que el ataque, propiamente hablando, ha terminado. El conocimiento ha vuelto, pero solo en parte, y durante cierto tiempo la enferma queda presa de un delirio de carácter variable, entrecortado por alucinaciones y acompañado a veces de algunos trastornos del movimiento. Ese delirio constituye un cuarto período por el que pasa la enferma antes de reencontrar su equilibrio normal. Es como un resto del ataque que se agota, y los accidentes que se presentan entonces son justamente comparables —y a veces incluso idénticos— a los que preceden al ataque y le sirven en cierto modo de preludio.

Entre los trastornos del movimiento que pueden observarse señalaremos contracturas generalizadas muy dolorosas, que imprimen a los miembros las posiciones más extrañas. Las enfermas, que han recuperado entonces el conocimiento al menos en parte, no pueden oponerse a esa suerte de calambres que retuercen sus miembros, sobre los cuales su voluntad ya no tiene ningún dominio. *¿Cómo no creer que un genio maligno las tortura?* Lanzas entonces gritos arrancados inconscientemente por el dolor, y ofrecen el cuadro más agitado y más lamentable.

El ataque regular, el ataque tipo, así compuesto de sus cuatro períodos, ocupa una duración media de un cuarto de hora; pero puede repetirse hasta constituir series de ataques cuyo número varía de veinte a doscientos y más. Se produce entonces una suerte de estado de mal que puede prolongarse varias horas e incluso más de una jornada.

Las variedades

Diversas variedades del ataque histérico se desprenden del tipo que acabamos de describir, sea por el aislamiento de un período, sea simplemente por su exageración con atenuación de los otros. Así, el primer período dará nacimiento a la *variedad epileptoide*; el segundo, a la *variedad demoníaca*; el tercero, a la *variedad extática*; y el cuarto, a la *variedad delirante*.

[Los autores desarrollan a continuación la variedad demoníaca período por período, para mostrar que es la que da a las antiguas posesiones su carácter aterrador. Ese desarrollo se omite en este recorte: puede consultarse en el original, pp. 103-105.]

Hemos demostrado así que la gran histeria cumplía un gran papel en las antiguas posesiones demoníacas, y que se la puede reencontrar allí bajo las formas más variadas —ataque epileptoide, ataque de contorsión o de grandes movimientos, ataque de éxtasis, de delirio, de letargia, de sonambulismo, de catalepsia—, sin olvidar la forma no convulsiva, caracterizada por las anestias, las hiperestesias especiales, las parálisis y las contracturas.

[Fin del recorte.]

Aparato de cátedra

Lo que sigue no pertenece a Charcot ni a Richer: es material de la cátedra.

Tres cosas para tener localizadas

En el texto	Qué dice	Por qué importa para Dora
La distinción entre actitudes ilógicas y actitudes pasionales	Las contorsiones del segundo período son «ilógicas»; las del tercero «son siempre la representación de una idea o de un sentimiento».	Charcot admite que una parte del ataque <i>significa</i> . Es el borde exacto de su clínica: lo constata y lo usa para clasificar, pero no pregunta qué significa. Freud entra por ahí.
«El enfermo entra él mismo en escena»	En el tercer período el enfermo representa un drama del que es protagonista, y se le escapan frases entrecortadas.	Hay una escena, un papel y palabras sueltas. Todo lo que le falta a ese cuadro para volverse un análisis es alguien que escuche las frases en vez de mirar las poses.
El contenido de las alucinaciones	Un jardín con flores rojas, el reencuentro con «el objeto de sus sueños o de sus afectos anteriores»; o incendios, guerra, sangre derramada.	Charcot registra el contenido y lo ordena en dos columnas, alegre y triste. No lo interroga. Con Dora, el contenido deja de ser un rasgo del cuadro y pasa a ser el material del trabajo.

Preguntas para llevar a clase

1. Charcot distingue las actitudes «ilógicas» de las «pasionales» porque estas últimas representan una idea o un sentimiento. ¿Por qué esa distinción, hecha con fines descriptivos, abre un problema que la descripción no puede resolver?
2. El texto dice que al enfermo «se le escapan frases entrecortadas». ¿Qué estatuto tienen esas frases en esta clínica? ¿Qué habría que cambiar para que tuvieran otro?
3. Charcot y Richer escriben este libro para demostrar que los endemoniados del arte eran históricos. ¿Qué gana la histérica al ser sacada de la posesión y puesta en la nosografía? ¿Y qué queda sin explicar?
4. Comparará la fase de las actitudes pasionales con lo que Freud hace con la tos de Dora. ¿Dónde está la diferencia: en lo que se observa o en lo que se pregunta?

Sobre esta traducción

Traducida del francés por la cátedra, sin intermediación de otra versión castellana. Se conservan los términos de época en su forma original (*clownismo*, *arco de círculo*, *actitudes pasionales*, *aura*, *estado de mal*). Las intervenciones de la cátedra van entre corchetes; los títulos de los cuatro períodos son los de los autores.

El original puede consultarse en la transcripción validada de Wikisource francés (*Les Démoniaques dans l'art*, pp. 91-101) y en el facsímil de la edición de 1887 enlazado desde allí.